Berufspolitisches Seminar

Aktuelles aus der Berufspolitik:
EBM-Weiterentwicklung

Ambulantes Operieren

AOP- Katalog

Sandra Sauer, Berlin

Berufsverband der
COLOPROKTOLOGEN
Deutschlands e.V.

No Conflict of Interests

Gesetzliche Aufträge zur Förderung der „Ambulantisierung“

§ 115b SGB V **Amb. Operieren im Krankenhaus, AOP**	**§ 115f (neu) SGB V** **Spezielle sektorengleiche Vergütung Verordnungs-ermächtigung**	**§ 115e SGB V** **Tagesstationäre Behandlung**
Auf Grundlage eines Gutachtens Vereinbarung: • AOP Katalog (neu: stationsersetzende Behandlungen) • Einheitliche Vergütungen für Krankenhäuser und Vertragsärzte	Spezielle Sektorengleiche Vergütung für bestimmte Leistungen des AOP-Kataloges, die unabhängig davon erfolgt, ob sie ambulant oder stationär erbracht werden	Einführung von Tagespauschalen in Krankenhäusern
31. Januar 2022	31. März 2023 - früheste Umsetzung mit Wirkung zum 1. Juli 2023	1. Januar 2023

Gesetzliche Aufträge zur Förderung der „Ambulantisierung“

	§ 115b SGB V Amb. Operieren im Krankenhaus, AOP	**§ 115f (neu) SGB V Spezielle sektorengleiche Vergütung Verordnungsermächtigung**	**§ 115e SGB V Tagesstationäre Behandlung**
Konzepte /Gutachten	Gutachten nach § 115b Abs. 1a SGB V des IGES Instituts 03/2022	Innovationsfondsprojekt Einheitliche, Sektorengleiche Vergütung, Projekt des hche, BKK, DKI, MiG der TU, Zi 09/22	Zweite Empfehlung der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung 09/2022

Gesetzliche Aufträge zur Förderung der „Ambulantisierung“

Vertragspartner	§ 115b SGB V Amb. Operieren im Krankenhaus, AOP	§ 115f SGB V Spezielle sektorengleiche Vergütung Verordnungs-ermächtigung	§ 115e SGB V Tagesstationäre Behandlung
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)	x	x	
Deutsche Krankenhaus-gesellschaft (DKG)	x	x	x
Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-SV)	x	x	x
Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV)			x

Gesetzliche Aufträge zur Förderung der „Ambulantisierung“

Vertragspartner	§ 115b SGB V Amb. Operieren im Krankenhaus, AOP	§ 115f SGB V Spezielle sektorengleiche Vergütung Verordnungs-ermächtigung	§ 115e SGB V Tagesstationäre Behandlung
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)	**Krankenhäuser und vertragsärztlicher Bereich**		**Krankenhäuser**
Deutsche Krankenhaus-gesellschaft (DKG)			
Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-SV)			
Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV)			

Gesetzliche Aufträge zur Förderung der „Ambulantisierung“ Leistungen

§ 115b SGB V AOP	§ 115f (neu) SGB V Spezielle sektorengleiche Vergütung Verordnungsermächtigung (SSV)	§ 115e SGB V Tagesstationäre Behandlung
• Ambulant durchführbare Operationen • Sonstige stationsersetzende Eingriffe • Stationsersetzende Behandlungen	• Leistungen des AOP Kataloges • Kriterien zur Auswahl: • hohe Fallzahl • kurze Verweildauer (max 3 Tage) • niedriger Komplexitätsgrad (PCCL kl.4)	• 6h ärztl./pfleger. Behandlung • Ausgenommen sind: • bereits existierende ambulante Behandlungsformen im Krankenhaus u.a. Notfall, AOP, SSV, Hochschulambulanzen, Geriatr. Amb., Spezial. Fachärztl. Versorgung • Belegärztl. Leistungen • Versicherte mit Anspruch auf häusliche Krankenpflege

Gesetzliche Aufträge zur Förderung der „Ambulantisierung“

Vergütung

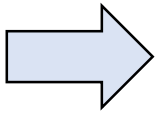
§ 115b SGB V Amb. Operieren im Krankenhaus, AOP
Einheitliche Vergütungen für Krankenhäuser und Vertragsärzte: • differenziert nach **Schweregrad der Fälle** • Betriebswirtschaftliche Grundlage ausgehend vom Einheitlichen Bewertungsmaßstab (**EBM**) • unter Berücksichtigung der nichtärztlichen Leistungen, Sachkosten, spezifischen Investitionsbedingungen

→ Gemäß KBV in Prüfung: Dreiseitiger Beschluss zum 1. April 2023

Gesetzliche Aufträge zur Förderung der „Ambulantisierung“

Schweregrade - Umsetzung

AOP - Vertrag
Erste Schritte im AOP Vertrag umgesetzt: • **Zeitzuschlag für Rezidiveingriffe** wenn die reale Dauer des Eingriffs die im EBM ausgewiesene Zeitkategorie des Eingriffs überschreitet • **Änderung der Kontextfaktoren** für stationär Durchführung der grundsätzlich ambulant durchzuführenden Operationen



Weiterentwicklung in Verhandlung bis 31.12.2023

- Vergütung erhöhter Betreuungsaufwände und erhöhter Nachbeobachtungs-aufwand gem. KBV

Gesetzliche Aufträge zur Förderung der „Ambulantisierung“

Schweregrade - Umsetzung

AOP Vertrag – § 10 Zeitzuschläge für Rezidiveingriffe des Abschnitt 1 des AOP Kataloges
• Definition Reoperation   • Wiedereröffnung eines Operationsgebietes zur Behandlung einer Komplikation   • Durchführung einer Rezidivtherapie   • Durchführung einer anderen Operation in diesem Operationsgebiet • Berechnung des Vergütungszuschlug für Reoperationen nur wenn diese nicht bereits über eigenständige OPS-Schlüssel abgebildet und spezifisch bewertet sind

Gesetzliche Aufträge zur Förderung der „Ambulantisierung“

Schweregrade - Umsetzung

AOP Vertrag – § 10 Zeitzuschläge für Rezidiveingriffe des Abschnitt 1 des AOP Kataloges
• Berechnung der Zuschlagspositionen im EBM für die Erbringung von Simultaneingriffen: • bis zu zweimal bei Eingriffen der Zeitkategorien 1, 2, 3 oder 4   • bis zu viermal bei Eingriffen der Zeitkategorien 5, 6 oder 7 • Zusätzlich zum Eingriff gemäß Abschnitt 1 AOP-Katalog ist der OPS-Zusatzkode 5-983 Reoperation zu dokumentieren • Die Schnitt-Naht- Zeit ist durch das OP- oder Narkoseprotokoll nachzuweisen

Gesetzliche Aufträge zur Förderung der „Ambulantisierung“

Schweregrade - Umsetzung

AOP Vertrag – Änderung der Kontextfaktoren
• Ablösung der bisherigen G-AEP-Kriterien und Kategorien der AOP-Verträge • Übergreifendes, patientenbezogenes und leistungsunabhängiges Modell basierend auf ICD- und OPS-Kodelisten • Arztvorbehalt ist geregelt bei medizinischen und sozialen Gründen

Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 wurde durch die KBV eine Verfeinerung zu einem differenzierten Kontextfaktorenmodell angekündigt

Gesetzliche Aufträge zur Förderung der „Ambulantisierung“

Schweregrade - Umsetzung

AOP Vertrag – Anlage 2 Kontextfaktoren
• 1451 ICD-Kodes (Haupt- / Nebendiagnosen)   • Viele Diagnosen, die per se schon gegen eine elektive Operation sprechen, wie schwere infektiöse Erkrankungen (z.B. kardiogener oder toxischer Schock)   • Schwer Kranke, z.B. Patienten mit einem apallischem Syndrom, Dekubitus IV. Grades bis hin zu schon Verstorbene – I46.0 Plötzlicher Herztod   • Krankheiten die mglw. mit einem erhöhten perioperativen Risiko einhergehen, wie z.B. Lungenemphysem, COPD mit FEV kl. 35%, komplikative Schwangerschaft, Thrombosen, rezidivierender Myokardinfarkt   • Operationsdiagnosen die zu einem erhöhten operativen Schwierigkeitsgrad führen, z. B. Rezidivhernien oder inkarzerierte Hernien mit Gangrän

Gesetzliche Aufträge zur Förderung der „Ambulantisierung“

Schweregrade - Umsetzung

AOP Vertrag – Anlage 2 Kontextfaktoren
• 1451 ICD-Kodes: • Relevante Diagnosen für die Proktologie: • K61.0 Analabszess   • K61.1 Rektalabszess   • K61.2 Anorektalabszess   • K61.3 Ischiorektalabszess   • Weitere mgl. televante Diagnosen: • Diagnosen in Zusammenhang mit Geburtstraumata

Gesetzliche Aufträge zur Förderung der „Ambulantisierung“

Schweregrade - Umsetzung

AOP Vertrag – Anlage 2 Kontextfaktoren
• 5693 OPS-Kodes   • u.a. neurochirurgische Operationen am Schädel oder der Hirnhäute, komplexe plastische Rekonstruktionen, Knochenmarkstransplantationen, viszeralchirurgische Eingriffe am Ösophagus, Magen, Dünndarm, Leber...   • Relevant für die Coloproktologie: • Sämtliche Eingriffe am Colorektum   • Komplexe Proktologische Eingriffe wie Sphinkterrekonstruktionen

Gesetzliche Aufträge zur Förderung der „Ambulantisierung“

Schweregrade - Umsetzung

AOP Vertrag – Anlage weitere Kontextfaktoren
• Schwere und sehr schwere motorische bzw. schwere kongnitive Funktionseinschränkungen (Barthelindex, Motorischer FIM) • Pflegegrade 4 und 5 • Beatmungszeit gemäß DKR von gr. 0 • Patient*innen bis Vollendung des 1. Lebensjahres • Nur für das Jahr 2023: bestimmte beidseitige Eingriffe des AOP Kataloges am Auge

Gesetzliche Aufträge zur Förderung der „Ambulantisierung“

Vergütung

§ 115e SGB V Tagesstationäre Behandlung
• Abrechnungsgrundlage DRG abzüglich anfallender Übernachtungskosten   • dies entspricht der 0,04 Bewertungsrelation je betreffender Nacht   • ein Abzug von mehr als 30% der Entgelte für den Aufenthalt darf nicht überschritten werden • Näheres oder Abweichendes zur Berechnung der Entgelte und der Prüfung der Notwendigkeit von Übernachtungen durch den Medizinischen Dienst, vereinbaren GKV-SV, DKG und PKV bis zum 27. Juni 2023.

Fazit

- Ein abschließendes Fazit kann bei noch zu vielen offenen Schritten noch nicht gezogen werden.
- Das Abweichen von der bisherigen Kalkulationsgrundlage des EBM für Leistungen der Speziellen Sektorengleichen Vergütung gem. § 115f SGB V bietet eine Chance auf eine sachgerechte Kalkulation für Leistungen des AOP Kataloges.
- Bis zu einer längerfristig kostendeckenden und Patienten individuellen ambulanten Versorgung ist es noch ein langer Weg.
  - Es fehlt eine grundsätzliche Falldefinition für einen ambulanten Fall (was gehört alles dazu?)
  - Neben der sachgerechten Vergütung, bedarf es auch der Anpassung von Versorgungsstrukturen als Gemeinschaftswerk durch Vertragsärzte und Krankenhäuser.
    - Die Einführung von Tagespauschalen gem. § 115e SGB V sind in diesem Zusammenhang konterkarierend.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!